

Desprendimiento de retina: signos de alarma y derivación urgente

1. Introducción y relevancia clínica

El **desprendimiento de retina (DR)** es una **urgencia oftalmológica mayor** caracterizada por la **separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario subyacente**, lo que interrumpe la nutrición de los fotorreceptores y produce una **pérdida visual potencialmente irreversible** si no se trata precozmente.

A nivel mundial, su incidencia es de aproximadamente **1 en 10.000 personas por año**, con mayor frecuencia en **adultos mayores, miopes altos y postoperados de catarata**.

En Chile, los casos de DR se concentran en población adulta activa, siendo una causa relevante de **pérdida visual súbita no dolorosa**.

El **reconocimiento temprano de los síntomas de alarma** y la **derivación inmediata a oftalmología** son fundamentales para salvar la visión.

En el **EUNACOM**, este tema se aborda con énfasis en:

- Diferenciar pérdida visual súbita por DR versus causas vasculares (oclusión arterial/venosa).
- Reconocer síntomas de alarma.
- Indicar manejo inicial correcto y derivación urgente.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional relevante

La retina está compuesta por:

- **Retina neurosensorial:** contiene los fotorreceptores (conos y bastones).
- **Epitelio pigmentario de la retina (EPR):** capa externa adherida a la coroides, que nutre y elimina desechos de los fotorreceptores.

La **adherencia entre ambas capas** depende de la presión intraocular, las uniones intercelulares y la integridad del vítreo.

Cuando la retina neurosensorial se separa del EPR, los fotorreceptores pierden su fuente de oxígeno y glucosa, lo que lleva a **necrosis retiniana irreversible en 48–72 horas** si no se trata.

2.2 Clasificación fisiopatológica

Tipo de desprendimiento	Mecanismo	Características clínicas
Regmatógeno (más frecuente, ~90%)	Rotura o desgarro retiniano permite paso de humor vítreo subretiniano.	Asociado a miopía, envejecimiento vítreo o trauma.
Traccional	Tracción mecánica de membranas fibrovasculares sobre la retina.	Típico en retinopatía diabética proliferativa.
Exudativo (seroso)	Acúmulo de líquido subretiniano sin rotura.	Causas inflamatorias, tumorales o vasculares (uveítis, coroides, metástasis).

2.3 Factores de riesgo

Factor	Mecanismo asociado
Miopía alta (> -6 dioptrías)	Adelgazamiento periférico y degeneración retiniana.
Edad > 50 años	Licuefacción vítrea y desprendimiento vítreo posterior (DVP).
Cirugía de catarata	Pérdida del soporte vítreo.

Trauma ocular	Desgarros periféricos.
Antecedente de DR en ojo contralateral	Riesgo 10–15%.
Retinopatía diabética proliferativa	Tracción fibrovascular.
Tumores oculares / uveítis crónica	Exudación subretiniana.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas de alarma (anamnesis orientada)

- Fotopsias (“destellos luminosos”)**
→ Por tracción vítrea sobre la retina.
- Miodesopsias (“moscas volantes”)**
→ Fragmentos vítreos o hemorragia inicial.
- Escotoma o sombra en cortina oscura**
→ Progresión del desprendimiento desde periferia al centro.
- Pérdida visual súbita, indolora y asimétrica.**
- Distorsión visual o metamorfopsias (si mácula afectada).**

□ *La tríada clásica de DR regmatógeno:*
Fotopsias + miodesopsias + sombra periférica progresiva.

3.2 Signos al examen físico

Signo	Hallazgo
Agudeza visual disminuida	Si mácula desprendida.
Fondo de ojo (oftalmoscopia indirecta)	Pliegues grisáceos móviles, despegamiento bulloso de retina.
Desgarro retiniano visible	Lesión ovalada o en herradura.
Movimientos ondulantes de retina al parpadear.	Típico de DR reciente.

Nota: Si el medio está opaco (hemorragia vítrea, catarata), puede requerirse **ecografía ocular modo B**.

3.3 Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencia clave
Desprendimiento vítreo posterior (DVP)	Fotopsias sin pérdida visual ni sombra; fondo normal.
Oclusión de arteria central de retina (OACR)	Pérdida visual súbita total; retina pálida con mácula rojo cereza.
Oclusión de vena central de retina (OVCR)	Visión borrosa, hemorragias en llama.
Migraña ocular (aura visual)	Escotomas bilaterales transitorios, sin hallazgos retinianos.

Uveítis posterior / coroiditis Inflamación, dolor, exudados.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En Atención Primaria (APS)

Examen	Utilidad
Agudeza visual (Snellen)	Cuantifica pérdida central o periférica.
Fondo de ojo directo (si disponible)	Puede observar pliegues retinianos o desgarro periférico.
Ecografía ocular (si opacidad de medios)	Confirmación rápida de DR.
Hallazgo clave: membrana móvil hiperecoica separada del polo posterior (en “V” invertida).	

4.2 En oftalmología especializada

Examen	Descripción	Utilidad
Oftalmoscopia binocular indirecta	Visualización detallada de retina periférica.	Diagnóstico definitivo y planificación quirúrgica.
OCT (Tomografía de Coherencia Óptica)	Visualiza mácula y extensión del desprendimiento.	Determina si mácula está aplicada o no.
Ecografía modo B	En caso de hemorragia vítrea o catarata.	Evalúa tracción o tumor asociado.

4.3 Criterios diagnósticos

Diagnóstico confirmado por:

1. **Desprendimiento de retina neurosensorial visible al fondo de ojo o ecografía.**
2. **Síntomas compatibles (fotopsias, sombra en cortina).**
3. **Hallazgo de desgarro o tracción vítrea.**

5. Tratamiento (según guías MINSAL / AAO / SOCHIOF)

El tratamiento siempre es quirúrgico y constituye urgencia oftalmológica.

5.1 Manejo inicial en APS

- **Derivación inmediata a oftalmología de urgencia (<24 h).**
- **Reposo relativo:** evitar movimientos bruscos o esfuerzo.
- **Oclusión ocular suave (sin presión).**
- **No administrar colirios ni fármacos tópicos sin indicación.**
- Si el paciente refiere pérdida visual súbita total → **derivar urgente sin dilatar pupila.**

5.2 Tratamiento especializado

Técnica	Descripción	Indicaciones
Fotocoagulación láser / Crioterapia	Sella desgarros retinianos antes del desprendimiento completo.	Desgarros o agujeros periféricos sin DR.

Retinopexia neumática	Inyección intravítrea de gas (SF6 o C3F8) + láser o crioterapia.	DR regmatógeno superior pequeño.
Cerclaje escleral (banda)	Cinta de silicona alrededor del globo ocular para aplanar retina.	DR primario sin proliferación vítrea.
Vitrectomía pars plana	Remueve vítreo y tracción; relleno con gas o silicona.	DR complicado, traccional o recidivante.

5.3 Factores pronósticos del éxito quirúrgico

Factor	Impacto pronóstico
Mácula aplicada al momento de cirugía	Excelente resultado visual.
Duración del desprendimiento < 5 días	Mejora tasa de re-aplicación.
Ausencia de proliferación vítreorretiniana (PVR)	Menor riesgo de recurrencia.
Cirugía oportuna y técnica adecuada	Éxito anatómico > 90%.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Consecuencia
Proliferación vítreorretiniana (PVR)	Formación de membranas fibrocelulares traccionantes.	Principal causa de fallo quirúrgico.

Re-desprendimiento retiniano	5–10% de casos, requiere reintervención.	Pérdida progresiva de visión.
Edema macular cistoide	Inflamación postoperatoria.	Disminución visual persistente.
Catarata secundaria	Frecuente tras vitrectomía.	Corrección con cirugía posterior.
Glaucoma secundario o hipertensión ocular	Por gas o silicona.	Control médico.

Pronóstico general:

- Con mácula aplicada: recuperación visual > 80%.
- Con mácula desprendida >10 días: visión final suele <20/200.
- Mortalidad visual depende del tiempo de evolución y tipo de DR.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Desprendimiento de retina = urgencia oftalmológica.**
2. **Fotopsias + moscas volantes + sombra periférica = signo de alarma.**
3. **Diagnóstico clínico**, no demorar derivación esperando exámenes.
4. En miopes o postoperados de catarata, tener **alto índice de sospecha**.
5. **Ecografía ocular** confirma DR si el fondo de ojo no es visible.
6. **Pronóstico visual depende de si la mácula está aún aplicada.**
7. **No hay tratamiento médico efectivo**, solo quirúrgico.

Errores comunes

- No derivar de inmediato (“esperar evolución”).
- Confundir DR con migraña ocular (transitoria).
- No advertir al paciente con DVP sobre síntomas de alarma.
- Intentar manejo en APS o indicar colirios.
- No identificar la pérdida visual como **indolora y súbita**.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **desprendimiento de retina** es una **urgencia oftalmológica que amenaza la visión**.
2. Su causa más frecuente es **regmatógena**, por ruptura retiniana.
3. Los **síntomas cardinales** son **fotopsias, miodesopsias y sombra en cortina**.
4. El **diagnóstico es clínico** y debe confirmarse con **fondo de ojo o ecografía**.
5. El **tratamiento es siempre quirúrgico**, idealmente dentro de 24–72 horas.
6. **Pronóstico visual depende de la mácula**: aplicada = visión preservada.
7. En APS, **derivación inmediata** sin intervenciones tópicas o dilatación.